



Coerção e Violência Institucional

A experiência da coerção e da violência institucional perpassa a vida das pessoas com sofrimento mental. São, então, objetos de uma violência social grave e contínua, com determinantes de classe, raça e gênero atuando de maneira interseccional, ou seja, várias características de uma pessoa se cruzam ao mesmo tempo e acabam influenciando juntas a forma como ela é tratada ou as dificuldades que enfrenta. E são objetos de coerção e violência institucional, estrutural, na sua relação com dispositivos de governo, incluindo os serviços psiquiátricos e de saúde mental.

Em territórios marcados por desigualdade, aquilo que chamamos de crise pode ser o momento em que a violência social se condensa: perda de renda, despejo, fome, humilhação, violência doméstica, ameaça territorial. A crise é psíquica e social porque o psiquismo não flutua acima do mundo.

A interseccionalidade, como leitura de cena, muda a pergunta clínica. Uma mulher em crise pode estar atravessando violência de gênero e coerções familiares; uma pessoa negra pode ser lida como “ameaça” mais rápido, inclusive por instituições de cuidado, aumentando a chance de restrição; uma pessoa trans pode reencontrar no serviço o mesmo roteiro de humilhação que encontra na rua.

A determinação social também exige atenção à linguagem. Palavras como “aderência”, “comportamental” e “alta” podem esconder julgamento. Às vezes, a pessoa não “abandona” o tratamento: há barreiras de acesso importantes e muitas vezes invisíveis para os trabalhadores de um serviço de saúde. Às vezes, a pessoa não “resiste ao vínculo”: ela se protege de uma instituição que já a feriu. Às vezes, não é “não quer”: é “não consegue agora”. Reconhecer isso não elimina responsabilidade, apenas ajuda a construir uma responsabilidade sanitária possível, proporcional às condições.

Daí uma consequência prática: um projeto terapêutico singular ou plano de crise sem proteção social é frágil. Benefícios, moradia, segurança, rede, acesso à UBS, articulação com assistência, pactos com a família, cuidado do corpo. A unidade mínima não é o indivíduo sozinho, mas o conjunto indivíduo-rede-território-instituição. A crise escala quando esse conjunto desorganiza e reduz quando esse conjunto recupera alguma estabilidade.

Por fim, essas determinações também atravessam o próprio serviço. A instituição trabalha sob pressão, metas, falta de recursos e violência territorial. Se não reconhece suas condições e limitações, pode descarregar no usuário sua impotência. Equidade, então, é prática de cena, é perceber quando um “padrão” supostamente neutro penaliza certos grupos (por exemplo, exigir documentação rígida de quem está na rua; exigir “família presente” de quem tem história de violência; exigir formalidade de quem nunca foi ouvido). Ajuste fino é isto: o serviço se adapta para reduzir barreiras, sem renunciar limites protetores que incluem, e não limites que expulsam.